FLASHCARDS — 40 cartes

Chaque carte présente une notion précise au recto et une réponse courte, expliquée au verso. Textes sélectionnables.

CARTE 01

RECTO • Quels sont trois repères d’une communication soignante adaptée ?

VERSO • Cohérence des paroles et des attitudes, prise en compte de la compréhension et adaptation à l’état psychologique.

EXPLICATION • Une communication adaptée articule cohérence verbal/non verbal, compréhension et état psychologique de la personne, plutôt que des formules automatiques.

CARTE 02

RECTO • Comment reconnaître une posture congruente ?

VERSO • Les paroles, l’attitude et les actes du soignant ne se contredisent pas.

EXPLICATION • La congruence est décrite comme un alignement entre pensée, expression et comportement ; elle favorise une posture authentique.

CARTE 03

RECTO • Pourquoi adapter son rythme après une annonce difficile ?

VERSO • L’état émotionnel peut limiter la disponibilité et la compréhension du patient.

EXPLICATION • La capacité à accueillir une information peut être temporairement limitée ; le rythme et la compréhension doivent être pris en compte.

CARTE 04

RECTO • Quel risque présente une discordance entre paroles et attitudes ?

VERSO • La personne peut ne pas se sentir entendue malgré des mots rassurants.

EXPLICATION • Dire que l’on écoute sans manifester une réelle disponibilité peut affaiblir la cohérence du message ; l’écran n’est pas en lui-même interdit.

CARTE 05

RECTO • Pourquoi la posture physique fait-elle partie de la communication ?

VERSO • Elle influe sur la possibilité de contact, d'attention et de participation de la personne.

EXPLICATION • La posture physique, l'orientation du corps et le regard participent à la qualité relationnelle ; ils sont adaptés à la situation.

CARTE 06

RECTO • Comment définir le besoin relationnel ?

VERSO • Besoin d'entrer ou de rester en relation avec un autre pour exprimer, partager, comprendre ou traverser ce que l'on vit.

EXPLICATION • Le besoin relationnel concerne l'entrée ou le maintien en relation pour exprimer, comprendre ou traverser une expérience vécue.

CARTE 07

RECTO • Quel indice simple peut signaler un besoin relationnel ?

VERSO • L'expression d'une inquiétude ou d'une difficulté, sans préjuger de sa cause.

EXPLICATION • Un propos sur l'inquiétude ou la difficulté vécue peut signaler une demande relationnelle, qu'il faut ensuite explorer avec prudence.

CARTE 08

RECTO • Comment accueillir une inquiétude sans projeter son interprétation ?

VERSO • Reconnaître les mots employés et demander ce qui inquiète plus particulièrement la personne.

EXPLICATION • L'énoncé ne permet pas de connaître la cause de l'inquiétude. L'écoute, la reformulation et l'ouverture sont prioritaires.

CARTE 09

RECTO • Peut-on associer technique et relationnel ?

VERSO • Oui : un soin technique peut ouvrir un temps pour écouter, comprendre et accompagner.

EXPLICATION • La dimension relationnelle s'inscrit fréquemment dans un geste technique : écouter une inquiétude ne dépend pas d'un acte spécifique.

CARTE 10

RECTO • Comment gérer un besoin d’écoute lorsque le temps manque ?

VERSO • Reconnaître la demande, convenir d’un retour réaliste et passer le relais si nécessaire.

EXPLICATION • Accueillir une demande d’écoute, organiser un retour et solliciter un relais sont préférables à l’abandon de l’échange.

CARTE 11

RECTO • Que caractérise l’attitude d’évaluation ?

VERSO • Porter une appréciation ou un jugement sur la personne et sa manière de réagir.

EXPLICATION • Porter un jugement sur ce que la personne devrait être ou ressentir risque de la culpabiliser et de fermer la conversation.

CARTE 12

RECTO • Quel est le piège de l’interprétation ?

VERSO • Proposer comme certain un sens ou un motif que la personne n’a pas elle-même exprimé.

EXPLICATION • Attribuer une cause précise sans l’avoir entendue revient à penser à la place de la personne et à projeter son propre raisonnement.

CARTE 13

RECTO • Pourquoi « tout va bien se passer » peut-il être maladroit ?

VERSO • Cette formule rassure sans savoir et peut minimiser l’inquiétude exprimée.

EXPLICATION • L’intention de rassurer peut être positive, mais une promesse non fondée peut faire sentir que l’inquiétude n’est pas entendue.

CARTE 14

RECTO • Comment reconnaître une attitude d’investigation-enquête ?

VERSO • Le soignant propose plusieurs hypothèses ou questions orientées plutôt que de laisser l’autre formuler son vécu.

EXPLICATION • Une liste de causes possibles proposées par le soignant restreint la parole et peut transformer l’entretien en enquête guidée.

CARTE 15

RECTO • Quel est le risque d’un conseil trop précoce ?

VERSO • Substituer la solution du soignant à l’expression des besoins et des choix du patient.

EXPLICATION • Le conseil impose une option formulée par le professionnel ; le travail en équipe peut être proposé sans prescrire à la place de l’autre.

CARTE 16

RECTO • Comment exprimer une attitude de compréhension ?

VERSO • Reprendre et reformuler le vécu exprimé, puis ouvrir un espace pour que la personne précise.

EXPLICATION • La reformulation reprend les mots et le sens apparent du propos sans attribuer une cause non exprimée.

CARTE 17

RECTO • Pourquoi le moment d’une réponse importe-t-il ?

VERSO • La même phrase peut produire un effet différent selon le vécu, l’instant et l’état de la relation.

EXPLICATION • Le moment et la formulation des réponses influencent leur effet : un jugement trop précoce peut provoquer culpabilité et fermeture du dialogue.

CARTE 18

RECTO • Quelles attitudes de Porter sont particulièrement directives ?

VERSO • Le conseil, l’enquête orientée et l’interprétation prématurée.

EXPLICATION • Solution rapide, enquête orientée et interprétation peuvent déplacer l’attention du vécu du patient vers les idées du soignant.

CARTE 19

RECTO • À quoi sert la grille des six attitudes ?

VERSO • À analyser le type de réponse et ses effets possibles sur la parole et la relation.

EXPLICATION • La grille d’analyse aide à reconnaître une posture et ses effets probables. Une réponse n’est pas évaluée hors de son contexte relationnel.

CARTE 20

RECTO • Comment proposer une ressource sans imposer ?

VERSO • Explorer les attentes de la personne et présenter une possibilité, sans choisir pour elle.

EXPLICATION • Les ressources doivent être recherchées avec la personne ; l’entourage et les autres professionnels peuvent être mobilisés selon ses besoins.

CARTE 21

RECTO • Quels trois repères sont associés à Carl Rogers ?

VERSO • Empathie, considération positive inconditionnelle et congruence.

EXPLICATION • L’empathie, la considération positive inconditionnelle et la congruence favorisent une posture d’écoute ouverte et authentique.

CARTE 22

RECTO • Qu’est-ce que l’empathie ?

VERSO • Une posture de compréhension du monde de l’autre, en restant conscient de ses propres émotions.

EXPLICATION • L’empathie cherche à comprendre sans confondre l’expérience du patient avec la sienne ni se laisser envahir par une projection.

CARTE 23

RECTO • Quelle idée exprime la considération positive inconditionnelle ?

VERSO • Reconnaître la valeur de la personne et ses ressources, sans faire dépendre le respect de son adhésion.

EXPLICATION • Cette posture reconnaît les capacités, valeurs et ressources de la personne et vise à l’accompagner sans décider à sa place.

CARTE 24

RECTO • Pourquoi dit-on que l’écoute est « active » ?

VERSO • Parce que l’on se rend disponible, questionne avec tact, reformule et facilite la parole.

EXPLICATION • L’écoute active ne se réduit pas à entendre : elle exige une présence corporelle et mentale, des relances adaptées et une attention au discours.

CARTE 25

RECTO • Quelle distinction retenir entre empathie et sympathie ?

VERSO • L’empathie vise la compréhension professionnelle ; la sympathie évoque une proximité affective ou amicale.

EXPLICATION • Une posture de compréhension professionnelle ne se confond pas avec une relation amicale, qui peut brouiller la distance relationnelle.

CARTE 26

RECTO • Donne un exemple de question ouverte.

VERSO • « Qu’est-ce qui vous inquiète plus particulièrement ? »

EXPLICATION • Une question ouverte permet à la personne de choisir ce qu’elle souhaite aborder sans être enfermée dans les hypothèses du soignant.

CARTE 27

RECTO • Quelle est la place d’une question fermée ?

VERSO • Obtenir une information précise lorsque c’est approprié, sans remplacer la parole libre.

EXPLICATION • Les questions fermées sont adaptées à une demande de réponse précise ; elles ne remplacent pas l’exploration ouverte du vécu.

CARTE 28

RECTO • À quoi sert la reformulation ?

VERSO • À vérifier, clarifier et accompagner le discours, sans imposer son propre sens.

EXPLICATION • La reformulation permet de vérifier une compréhension, soutenir le récit et laisser la personne corriger ce qui a été mal entendu.

CARTE 29

RECTO • Comment clarifier sans interpréter ?

VERSO • Faire préciser un mot ou une expression employée par la personne.

EXPLICATION • La clarification reprend un mot ou une expression ambiguë pour demander à la personne ce qu’elle entend réellement.

CARTE 30

RECTO • À quoi peut servir un silence ?

VERSO • À donner le temps de réfléchir, de ressentir et de reprendre sa parole.

EXPLICATION • Le silence peut aider la personne à se recentrer et à retrouver ses mots ; son sens ne doit pas être supposé automatiquement.

CARTE 31

RECTO • Que comprend le paraverbal ?

VERSO • Les caractéristiques de la voix : timbre, intensité, rythme, débit et pauses.

EXPLICATION • Le paraverbal comprend la voix, le timbre, la puissance, le rythme et le débit.

CARTE 32

RECTO • Quels repères non verbaux observer ?

VERSO • Regard, posture, distance, mimiques et toucher adapté si cela convient à la personne.

EXPLICATION • Le regard, la posture, la proxémie et les mimiques participent à la communication ; un toucher éventuel doit être adapté et autorisé.

CARTE 33

RECTO • Toucher empathique ou gnosique : quelle différence ?

VERSO • Empathique : soutien relationnel. Gnosique : recueil d’informations cliniques.

EXPLICATION • Le toucher empathique soutient la relation ; le toucher gnosique recherche des signes cliniques. Leur usage reste adapté à la personne.

CARTE 34

RECTO • Que faire devant un signe non verbal ambigu ?

VERSO • L’observer et l’explorer avec tact plutôt que d’en déduire une signification certaine.

EXPLICATION • Le sens d’un comportement non verbal dépend du contexte ; il ne permet pas à lui seul d’attribuer une émotion ou une intention.

CARTE 35

RECTO • Pourquoi reconnaître ses émotions de soignant ?

VERSO • Pour éviter qu'elles dirigent l'entretien et rester disponible à la personne.

EXPLICATION • Des émotions peuvent naître chez le soignant ; elles doivent être reconnues et régulées, sans être imposées au patient.

CARTE 36

RECTO • Comment préserver la distance relationnelle ?

VERSO • Prendre conscience de ses émotions, les réguler et solliciter un relais si nécessaire.

EXPLICATION • La distance relationnelle consiste à reconnaître et canaliser ses propres émotions ; le relais professionnel peut être utile quand la disponibilité n'est plus suffisante.

CARTE 37

RECTO • Quelle place pour l'équipe dans la relation d'aide ?

VERSO • Proposer des ressources adaptées et transmettre les éléments nécessaires, sans abandonner l'écoute.

EXPLICATION • Transmissions, ressources associatives et travail interdisciplinaire complètent l'écoute ; orienter ne signifie pas abandonner la relation.

CARTE 38

RECTO • Quelle réponse initiale privilégier devant une inquiétude après une mastectomie ?

VERSO • Reconnaître l'inquiétude, se rendre disponible et inviter la personne à préciser ce qui la préoccupe.

EXPLICATION • La situation travaillée conduit à reconnaître l'émotion, ouvrir l'échange et adapter sa disponibilité avant de proposer une solution.

CARTE 39

RECTO • Quel mémo d'entretien appliquer ?

VERSO • Accueillir → reformuler → explorer → accompagner selon les attentes exprimées.

EXPLICATION • L'observation, la reformulation et la question ouverte précèdent les hypothèses ; la personne reste la mieux placée pour définir son vécu.

CARTE 40

RECTO • Quel est le but principal de l’écoute active ?

VERSO • Faciliter l’expression du vécu, la compréhension mutuelle et une relation de confiance.

EXPLICATION • L’écoute relationnelle vise la compréhension, la confiance et la mobilisation des ressources propres au patient, non l’adhésion forcée à une réponse du soignant.